

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient's Copy
Cholangiogram (Percutaneous)
&/or Biliary Drain/Stent

معلومات الإقرار – نسخة المريض
تصوير القنوات المرارية عن طريق
الجلد مع/أو التصريف المراري/ وضع دعامة

1. What is a Cholangiogram &/or Biliary Drain/Stent Insertion?

A cholangiogram is an x-ray procedure that looks at your gall bladder and bile ducts. It is done by placing a needle into your bile duct, injecting Iodinated Contrast Media (once called x-ray dye) and taking x-ray images.

Depending on your condition you may also require a biliary stent or drain to be inserted.

A biliary drain is a small flexible catheter (tube) that is inserted through your skin and into the bile ducts to drain away your bile. The doctor will discuss how long you will need the drain.

A biliary stent is used instead of surgery to deal with a narrowed or blocked bile duct. It is an internal drainage tube placed in your bile duct to stop or to temporarily relieve an obstruction causing the blockage. This stent stays in for life.

The insertion of a biliary drain and/or a stent is done as an extra step to the cholangiogram procedure.

This procedure is performed in medical imaging with guidance from imaging machines such as ultrasound and x-ray.

2. Will there be any discomfort, is any anesthetic needed?

This procedure will require an injection of local anesthetic and the use of a sedation or general anesthetic. If you are booked for a general anesthetic you will have a pre-anesthesia check up.

3. What is sedation?

Sedation is the use of drugs that give you a 'sleepy-like' feeling. It makes you feel very relaxed during a procedure that may be otherwise unpleasant or painful. You may remember some or little about what has occurred during the procedure.

This procedure may only have a light sedation. You need to be able to fully co-operate at times by holding your breath when instructed by the doctor.

Sedation is generally very safe but has a risk with side effects and complications. Whilst these are usually temporary, some of them may cause long-term problems.

The risk to you will depend on:

- Whether you have any other illness
- Personal factors, such as whether you smoke or are overweight.

4. Preparation for the procedure

The medical imaging department will give you instructions on how to prepare for your procedure.

1. ما هو تصوير القنوات المرارية عن طريق الجلد؟ أو التجفيف المراري/الدعامة المرارية ؟

تصوير القنوات المرارية هو إجراء يتم بالأشعة السينية للكشف على الحويصلة المرارية (المرارة) والقنوات المرارية. يتم الإجراء عبر وضع إبرة في القناة المرارية ، حقن مادة وسط متباين (تسمى سابقاً صبغة الأشعة السينية) وأخذ صور بالأشعة السينية.

وبناء على حالتك المرضية ، فقد يتم أيضاً وضع أنبوب تجفيف (تصريف) أو دعامة .

أنبوب التجفيف المراري هو عبارة عن قسطرة صغيرة ومرنة توضع في القنوات المرارية عن طريق الجلد لسحب وتصريف مادة الكبد الصفراء. سيناقش معك الطبيب الفترة الزمنية اللازمة لبقاء الأنبوب في قنواتك المرارية.

الدعامة المرارية تستخدم كبديل للجراحة لعلاج تضيق أو انسداد القناة المرارية. هي عبارة عن أنبوب تصريف داخلي يوضع في القناة المرارية لإيقاف أو العلاج المؤقت للانسداد المسبب لانغلاق القناة المرارية. تظل الدعامة مدى الحياة.

إدخال أنبوب التجفيف (التصريف) وأو الدعامة المرارية يعتبر خطوة إضافية بجانب تصوير القنوات المرارية.

يتم الإجراء في قسم التصوير الطبي تحت توجيه من جهاز تصوير مثل جهاز الموجات فوق الصوتية أو الأشعة السينية.

2. هل سيكون هناك شعور بعدم الراحة ؟ هل هناك حاجة لأي دواء تخدير؟
يتطلب الإجراء حقنة من مخدر موضعي مع استخدام دواء مسكن أو تخدير كلي. إذا كنت ستجري الفحص تحت التخدير الكلي نرجو منك التوجه لقسم التخدير للفحص المسبق.

3. ماذا يعني التسكين (إعطاء دواء مسكن)؟
هو إعطاء دواء يعطيك شعور بالنوم ويجعلك مسترخ جداً خلال الإجراء ، حيث أن القيام بهذا الإجراء دون إعطاء مسكن قد يكون مزعج ومؤلم. قد تكون لديك القدرة لتذكر بعض مما حدث أثناء القيام بالإجراء. في هذا الإجراء تعطى مسكن خفيف . من المهم أن تكون أن تكون قادراً على التجاوب التام مع الطبيب عندما يطلب منك أحياناً حبس أنفاسك.

الدواء المسكن بشكل عام آمن ، إلا أن كل دواء له مخاطره وآثاره الجانبية و مضاعفاته ، وعلى الرغم أن غالبيتها تكون مؤقتة ، إلا أن البعض منها قد تكون له مشاكل طويلة الأمد.

المخاطر بالنسبة لك تتوقف على:

- إذا كنت مصاب بأمراض أخرى .
- عوامل شخصية مثل التدخين أو زيادة الوزن.

4. التحضير للإجراء

يقوم قسم التصوير الطبي بإعطائك التعليمات المتعلقة بكيفية التحضير لهذا الإجراء.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- You will be told when to have your last meal and drink. This is to make sure your stomach is empty so that if you vomit during the procedure there will be nothing to go into your lungs.
- Please tell the staff if you are or suspect you might be pregnant.
- If you take Aspirin, Warfarin, Clopidogrel (Plavix and Iscover) or Dipyridamole (Persantin and Asasantin) or any other drug that is used to thin your blood ask your doctor/health practitioner if you should stop taking it before the procedure as it may affect your blood clotting.
- List or bring all your prescribed drugs, those drugs you buy over the counter, herbal remedies and supplements.
- Do not drink any alcohol and stop recreational drugs 24 hours before the procedure as these may alter the affects of the sedation anesthetic. If you have a drug habit, please tell your doctor.

5. During the procedure

A fine needle (IV cannula) will be inserted into a vein in your arm.

The Radiologist (x-ray doctor) will inject local anesthetic into your skin.

A small cut will be made into the skin.

Using ultrasound as a guide the Radiologist will insert a needle through your skin and into your bile duct.

You must remain as still as possible. At times, you may be asked to hold your breath.

The cholangiogram will be performed by injecting contrast into your bile ducts and taking x-ray images.

If required a biliary stent may be inserted. This is done through the same cut in the skin and by sliding the stent over a wire that has passed through the narrowing in the bile duct.

A biliary drain may be inserted into the bile duct. It will be connected to a drainage bag to collect the bile. The biliary drain may be sutured to help keep it in place and a dressing applied.

6. After the procedure

The recovery time varies depending on the procedure you have had and the anesthetic given. It varies between 2 hours to 6 hours.

The IV cannula will be removed after you have recovered.

7. What are the risks of this specific procedure?

The risks and complications with this procedure can include but are not limited to the following.

Common risks and complications include:

- Minor pain, bruising and/or infection from the IV cannula. This may require treatment with antibiotics.
- Pain or discomfort at the puncture site. This may require medication.

- سيتم إبلاغك بأخر موعد يمكنك فيه تناول الطعام والشراب لأنه من المهم أن تكون معدتك فارغة أثناء الفحص ، لتلافي أي تقيؤ قد يؤدي إلى دخول المادة المتقيئة إلى الرئتين.

- نرجو إبلاغ الموظفين إن كنت حاملاً أو تشكين في كونك حاملاً .
- إن كنت تتناول أيأ من الأدوية التي تزيد من سيولة الدم كالأسبرين ، وارفارين ، كلوبيدوجريل (بلافكس أو اسكوفير) أو دايبيير دامول (بيرسانتين أو اساسانتين) أو أي عقار آخر لنفس الغرض ، فاسأل طبيبك إن كان عليك التوقف عن تناولها قبل الإجراء لأنها قد تؤثر على تخثر دمك.
- احضر معك كل الأدوية الموصوفة لك ، والأدوية التي تبتاعها دون وصفة ، والعلاجات العشبية والعلاجات التكميلية أو احضر قائمة بها.
- لا تحتسي الكحوليات وأوقف تعاطي كل الأدوية والعقاقير الترفيهية التي تتناولها ، وذلك قبل 24 ساعة من الإجراء ، لأنها قد تتداخل مع عمل الدواء المسكن. إذا كنت معتاداً على عقار معين ، نرجو إبلاغ الطبيب.

5. أثناء الإجراء

يتم وضع إبرة صغيرة في احد أوردة ذراعك (الخط الوريدي).

يقوم طبي الأشعة بحقن المخدر الموضعي في جلدك.

يتم عمل شق جراحي صغير في الجلد.

بتوجيه من الموجات فوق الصوتية، يقوم الطبيب بإدخال إبرة داخل القناة المرارية عبر الجلد.

يجب عليك البقاء ثابتاً دون حركة قدر الإمكان. قد يطلب منك في وقت ما من الإجراء حبس أنفاسك.

يتم عمل تصوير القنوات المرارية عن طريق حقن مادة وسط متباين معالجة باليود في قنواتك المرارية وأخذ صور بالأشعة السينية.

عند الضرورة قد يتم وضع دعامة مرارية . يتم ذلك عبر نفس الشق الجراحي في الجلد عن طريق تمرير (زحلقة) الدعامة على سلك قد تم تمريره في موضع الضيق في القناة المرارية.

قد يوضع أنبوب التصريف المراري داخل القناة المرارية . يتم وصل الأنبوب بكيس تصريف خارج الجسم لتجميع المادة الصفراء. قد تتم خياطة أنبوب التصريف لمنع خروجه من مكانه ، ثم يوضع الضماد.

6. بعد الإجراء

فترة النقاهة بعد انتهاء الإجراء تعتمد على طبيعة الإجراء الذي خضعت له ونوعية التخدير الذي تلقته ، وتتراوح ما بين 2-6 ساعات ، ويتم بعدها إزالة الخط الوريدي.

7. ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء بالتحديد ؟

مخاطر ومضاعفات هذا الإجراء تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر ومضاعفات شائعة وتشمل :

- ألم بسيط ، كدمة و \ أو عدوى بسبب إدخال الخط الوريدي. قد تتطلب معالجة بالمضادات الحيوية.
- ألم وشعور بعدم الراحة في موضع دخول إبرة العينة. قد يتطلب ذلك أدوية.
- حدوث نزيف أو كدمة . وهو أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Bleeding or bruising may occur. This is more common if you take Aspirin, Warfarin, Clopidogrel (Plavix and Iscover) or Dipyridamole (Persantin and Asasantin).
- The catheter may become kinked or blocked. Sometimes it needs to be moved or replaced.
- Failure of local anaesthetic which may require a further injection of anaesthetic or a different method of anaesthesia may be used.
- Nerve damage, is usually temporary, and should get better over a period of time. Permanent nerve damage is rare.
- The stent/drain may move or become blocked. It may need to be replaced or removed.
- Pain, this may require medication.

Less common risks and complications include:

- Infection, requiring antibiotics and further treatment.
- Damage to surrounding structures such as blood vessels, organs and muscles, requiring further treatment.
- Excessive bleeding from the puncture site. This may require other treatment and/or corrective surgery.
- An allergy to injected drugs, requiring further treatment.
- Bile leak, this may require further treatment.
- The procedure may not be possible due to medical and/or technical reasons.

Rare risks and complications include:

- An increased lifetime cancer risk due to the exposure to x-rays.
- Skin burns or damage from exposure to x-rays.
- Seizures and/or cardiac arrest due to local anesthetic toxicity.
- Death as a result of this procedure is very rare.

If sedation is given extra risks include:

- Faintness or dizziness, especially when you start to move around
- Fall in blood pressure
- Nausea and vomiting
- Weakness
- An existing medical condition getting worse
- Heart and lung problems such as heart attack or vomit in the lungs causing pneumonia. This may require emergency treatment
- Stroke resulting in brain damage.

Risks of Iodinated Contrast for patients with renal impairment:

There is a specific risk of giving Iodinated Contrast Media to patient's identified as having *Renal Impairment*. Giving the Contrast to people with weakened kidneys (renal impairment) can cause further kidney damage, which may in turn cause the kidneys to stop working properly (acute renal failure).

- تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو إسكوفير) أو عقار داباير دامول (بيرسانتين أو اساسانتين). قد يحدث التواء أو انسداد للقسطرة وقد تكون هناك حاجة لإزالتها أو استبدالها.
- فشل في عمل المخدر الموضعي مما قد يتطلب إعطاء حقنة أخرى أو استخدام طريقة تخدير أخرى.
- ضرر لعصب . غالباً ما يكون مؤقتاً و من المفترض تحسنه مع الوقت . من النادر حدوث ضرر دائم للعصب.
- قد تتحرك الدعامة الأنبوب التصريف من موقعها أو قد تنسد . قد تكون هناك حاجة لإزالتها أو استبدالها.
- ألم . قد يتطلب المعالجة بأدوية.

مخاطر ومضاعفات غير شائعة وتشمل :

- عدوى يتطلب علاجها المضادات الحيوية وعلاجات أخرى.
- ضرر الأنسجة المجاورة كالأوعية الدموية ، الأعضاء الأخرى والعصلات . يتطلب معالجات أخرى.
- نزيف مفرط من موضع دخول الإبرة . قد يتطلب ذلك علاج آخر وأو جراحة تصحيحية.
- تفاعل تحسسي للأدوية التي أعطيت أثناء القيام بالإجراء تتطلب علاجات أخرى.
- تسرب المادة الصفراء مما قد يتطلب معالجة أخرى.
- قد لا يمكن القيام بالإجراء لأسباب طبية وأو فنية (تقنية).

مخاطر ومضاعفات نادرة الحدوث وتشمل:

- زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان خلال الحياة بسبب التعرض للأشعة السينية.
- حروق أو ضرر للجلد بسبب التعرض للأشعة السينية.
- تشنجات و \ أو سكتة قلبية بسبب سمية المخدر الموضعي.
- الوفاة بسبب هذا الإجراء نادرة جداً .

مخاطر إضافية عند استخدام الدواء المسكن:

- إغماء أو دوخة ، خاصة عند بدء الحركة بعد الانتهاء من الإجراء .
- انخفاض في ضغط الدم.
- غثيان وقيئ.
- ضعف عام.
- تفاقم أي مشكلة صحية أخرى.
- مشاكل في القلب والرئتين كالأزمة القلبية أو دخول المادة المتقينة إلى الرئة مسببة التهاب رئوي مما قد يتطلب تدخل طبي طارئ.
- سكتة دماغية تتسبب في ضرر للمخ

مخاطر مادة الوسط المتباين المعالجة باليود عند المرضى المصابين باعتلال عمل الكلى.

المخاطر المحددة لمادة الوسط المتباين المعالجة باليود عند المرضى المصابين باعتلال عمل الكلى.
إعطاء مادة الوسط المتباين لمرضى يعانون من ضعف عمل الكلى قد يسبب أضراراً إضافية للكلى ، مما قد يسبب توقف الكلى عند العمل بشكل صحيح (فشل كلوي حاد).

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

8. What are the safety issues?

If a biliary drain has been left in, take care not to pull on the tube. Notify staff if the tube has fallen out.

Notes to talk to my doctor/health practitioner about:

8. ما هي الأمور المتعلقة بالسلامة بعد مغادرة المستشفى؟
إذا قام الطبيب بترك أنبوب التصريف المراري داخل الجسم ، فكن حذراً من تعرضه لأي سحب . أبلغ موظف القسم إذا خرج الأنبوب من موضعه.

أمور أتناقش حولها مع طبيبي :
